

Transcrição do podcast de revisão do Módulo: O Itinerário de Cuidado à Saúde, Agravos e Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis no Âmbito da PNAISP

Caio: Olá, hoje a gente mergulha num dos cenários de saúde mais, ah, desafiadores do Brasil: o sistema prisional.

Vivian: Exato. Vamos tentar entender os principais problemas que afetam as pessoas privadas de liberdade, desde, sei lá, as doenças infecciosas até as necessidades bem específicas de mulheres e da população LGBTQIA+.

Caio: Isso. E o que a gente percebe é um padrão muito claro: a prisão funciona como um, um amplificador de vulnerabilidades.

Vivian: Um amplificador... é. A gente vai conectar as condições de vida, o perfil dessa população e as doenças que mais aparecem. E o ponto mais importante é que a saúde dentro dos muros está diretamente ligada à saúde pública aqui fora. Não existe um muro que isola a doença.

Caio: Ok, vamos começar pelo panorama geral. Qual que é o perfil da população privada de liberdade e quais são os maiores riscos que ela enfrenta?

Vivian: O perfil, assim, é predominantemente de homens jovens, pretos ou pardos, com baixa escolaridade. As principais causas de óbito são agressões, doenças infecciosas e, infelizmente, suicídio.

Caio: E a superlotação, imagino?

Vivian: A superlotação e as condições precárias criam um ambiente ideal para a disseminação de tudo isso.

Caio: E aqui é onde fica muito interessante. Falando em doenças, a tuberculose parece ser um desafio gigantesco, certo?

Vivian: Sem dúvida. A tuberculose é talvez o exemplo mais dramático. Estudos genômicos mostram que mais da metade dos casos de tuberculose em pessoas fora do sistema prisional estão ligados a cadeias de transmissão iniciadas lá dentro.

Caio: Espera um pouco, mais da metade?

Vivian: Mais da metade. Ou seja, os muros são porosos. E esse mesmo ambiente favorece altas taxas de HIV, outras ISTs, hanseníase e infecções de pele.

Caio: Isso transforma a saúde prisional numa questão de saúde pública para todo mundo. E imagino que essa lógica se aplique de formas diferentes para grupos com necessidades distintas. E as mulheres? Como fica a saúde delas nesse ambiente?

Vivian: Para as mulheres, a gente vê uma prevalência maior de HPV, por exemplo, o que leva a um risco maior de câncer de colo de útero, mas também não podemos deixar de citar a incidência de câncer de mama no sistema prisional.

Caio: E o acompanhamento disso?

Vivian: Essas doenças muitas vezes não são acompanhadas e nem tratadas adequadamente. E para gestantes, o cenário é ainda mais delicado, com dificuldades no acesso ao pré-natal e violações de direitos.

Caio: Um direito básico que se torna um privilégio. Falando em direitos e sobre a população LGBTQIA+, quais são as peculiaridades?

Vivian: O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, agora permite que a pessoa trans escolha ser custodiada em unidades masculinas ou femininas.

Caio: O que é um avanço.

Vivian: É um avanço importante. Mas a grande dificuldade na prática é o acesso à terapia hormonal.

Caio: E o que acontece na falta desse acesso?

Vivian: Aí muitas pessoas recorrem a procedimentos perigosos, como a aplicação de silicone industrial, que causa complicações gravíssimas de difícil manejo.

Caio: Então, o que tudo isso significa? Parece que até áreas básicas como a saúde bucal acabam refletindo esses problemas sistêmicos.

Vivian: Exatamente. A saúde bucal funciona como um espelho da saúde integral. A prevalência de cárie, doença periodontal e até câncer de boca é altíssima.

Caio: E tem uma ligação direta com outras doenças.

Vivian: Sim, claro. Essas condições estão ligadas a doenças sistêmicas, como HIV e diabetes. Muitas vezes, uma lesão na boca é o primeiro sinal de algo maior. Cuidar da saúde bucal é uma questão de dignidade e um direito humano fundamental. No fim, fica claro que a saúde no sistema prisional não é um problema isolado. As falhas e os acertos no cuidado dessas pessoas, regidos pela PNAISP, têm um impacto direto e mensurável na saúde de toda a sociedade.

Caio: Isso nos deixa com uma reflexão final: considerando as enormes barreiras para oferecer até o cuidado mais básico, como o sistema pode evoluir para que a saúde física, mental e bucal seja vista não como um benefício, mas como a base indispensável para a reabilitação e a reintegração social?